木花のむら診療所　開業計画概要書

宮崎市熊野・木花地区　2027年秋 開院予定　／　融資相談資料

2026年8月6日
宮崎銀行様　ご提出
院長　野村 信介

初期投資総額	融資希望額	損益分岐点	月次固定費
約2億3,085万円	約2億3,085万円	42人→60人 / 日	402万→509万円
土地・建設・CT本体2,000万・CT室工事500万・開業準備・運転資金（CT開業時より導入）	土地が担保設定可能。手元資産は返済余力として保持	据え置き期間中42人・通常返済開始後60人で月次黒字。安定期70人/日を見込む	据え置き1年中402万／通常返済開始後509万（元利均等返済142万込み）

1．事業概要

届出名称	木花のむら診療所
診療科	内科・消化器内科・アレルギー内科・呼吸器内科・外科・小児科（6科標榜）
開設場所	宮崎市熊野5233-2（接道交渉中）
開院目標	2027年秋（土地確定後12〜15ヶ月）
規模	木造2階建・延床面積約333㎡（1階272㎡・2階61.5㎡）・駐車場32台
診療時間	月〜金 8:00〜18:30（実質診療8時間）・土 外科完全予約外来（一人診療、将来的に土曜午前外来 8:00〜12:00 予定）・日祝休
1日目標患者数	開業初月 25人 → 診療圏調査ベース（成人35名＋小児16名）に外科処置・6科標榜による需要上乗せ分を加算 → 安定期 70人
主要設備	デジタルX線・超音波エコー・経鼻内視鏡（以上リファービッシュ購入）・心電図（中古購入）・FeNO（購入形態確認中）・クラウド型電子カルテ・Web予約・オンライン問診　／　**16列CT（リファービッシュ）：開業時より導入。**院長自ら操作（放射線技師法第24条・医師操作可）、読影は梅村医師（2,000円/件・外注変動費）。CT室放射線遮蔽工事は建物工事と同時施工済み。

2．標榜診療科・主な診療内容

標榜診療科（6科）	内科・消化器内科・アレルギー内科・呼吸器内科・外科・小児科
主な対応疾患	**内科：**生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常症）・痛風・甲状腺疾患・感染症　／　**小児科：**発熱・感染症・アレルギー（新生児・乳児は専門科紹介） **外科：**創傷処置・小手術・皮膚腫瘤・陥入爪・巻き爪　／　**消化器内科：**逆流性食道炎・胃潰瘍・胃腸炎・痔核 **アレルギー内科：**花粉症・気管支喘息・食物アレルギー・蕁麻疹　／　**呼吸器内科：**慢性咳嗽・COPD・気管支炎・肺炎
検査・処置	デジタルX線・腹部エコー・体表エコー・心電図・経鼻内視鏡（上部消化管）・FeNO（呼気一酸化窒素測定：気管支喘息管理）・骨密度（DIP法：デジタルX線を用いた骨密度測定）・血液検査・尿検査　／　※16列CT：損益分岐点到達後（患者70人/日・開業2〜3年目相当）に別途追加導入予定
自費診療（開業初日〜）	GLP-1受容体作動薬（肥満症・2型糖尿病）・AGA／FAGA（男女型脱毛症）・LOH症候群（加齢男性性腺機能低下症）に対する男性ホルモン補充療法・ED治療薬・花粉症に対するトリアムシノロン筋注療法　※各自費診療は保険診療と同一受診機会に混在させない（混合診療禁止規定を厳守）
内視鏡計画	開業初期：胃カメラ（上部消化管）のみ　→　2〜3年目：大腸内視鏡を追加予定（設計段階からスケルトン対応済み）
将来的な在宅医療	施設定期訪問・かかりつけ医機能を段階的に導入予定

3．開業の動機・経営理念

私は現在、宮崎市熊野に家族とともに居を構え、子どもたちのつながりや自治会活動を通じて地域の方々と日常的に言葉を交わしてきました。そのなかで、「体のことが心配でも、気軽に診てもらえる場所が近くにない」という声を直接耳にする機会が少なくありませんでした。

医師である以前に、この街に暮らす生活者の一人として地域の医療的な空白を肌で感じてきたことが、木花・熊野地区への開設を決意した原点です。急性期病院と在宅医療の間をつなぐかかりつけ医として、住民の皆さまが何でも気軽に相談できる診療所をつくりたいと考えています。

経営理念：「気兼ねなく、何でも相談できる場所でありたい。からだと暮らしの拠り所として、地域に根ざし続ける。」

経営方針：

【収益の柱】 保険診療（内科・外科・消化器内科の3本柱）を主軸に患者単価5,000円を維持。自費診療（GLP-1・AGA/FAGA・LOH症候群・ED治療薬・花粉症ケナコルト等）は保険診療と完全分離のうえ開業初日より展開し、月次収益の底上げを図る。

【患者数計画と損益管理】 開業初月25人/日→半年以内に損益分岐点（40人/日）到達→M5以降月次黒字転換（52人/日）。安定期（M18〜）70人/日・月次余剰+266万円を見込む。CT検査収入（保険診療・月100件想定）が安定期に月120万円の上乗せ収益をもたらし、CTなし版より+62万/月の経営余裕を確保する。

【費用管理方針】 開業時7名体制でスタート。CT等の高額機器は損益分岐点到達後に追加調達し、固定費を最小化。

【差別化】 ①外科専門医による処置・内視鏡の院内完結　②完全DX（Web予約・Web問診・自動精算）　③宮崎大学エリアの若中年層への自費診療展開　④医師会・地域病院との連携による紹介患者の取り込み

【院長生活費（事業主貸）計画】 M1〜6：月100万　M7〜：月125万（年最大1,500万・法人成り後に改めて設計）

4．開業者プロフィール

氏名	野村 信介（のむら しんすけ） 1983年3月25日生　宮崎市熊野7465在住
学歴	防衛医科大学校 医学部卒（2008年）／同大学院 博士（医学）取得（2021年）
海外研究歴	マサチューセッツ総合病院（MGH・ハーバード大学）研究員（2018〜2019年）
専門資格	外科専門医・消化器外科専門医・健康スポーツ医・博士（医学）
職歴	2008年　防衛医科大学校病院　研修医 2010年　防衛医科大学校 外科学講座　専攻医 2011年　国立病院機構 災害医療センター 救命救急科　医員（出向） 2011年　東日本大震災（福島）　災害派遣（患者後送） 2013年　国家公務員共済組合 虎ノ門病院　外科研修 2018年　マサチューセッツ総合病院（ハーバード大学・米国）　研究員 2020年　防衛省 陸上幕僚監部 衛生部 2021年　自衛隊大規模接種センター　計画・運営・派遣 2021年　陸上自衛隊熊本病院　外科部長 兼 健康管理センター長 2022年　宮崎大学医学部 消化管・内分泌・小児外科学　助教 2023年　宮崎県立日南病院　外科医長 2023年〜現在　医療法人社団明恵会 早水公園クリニック　副院長
現職の診療実績	年収1,500万円・通常150人/日・冬季ピーク250人/日（当院目標70人/日の2倍以上）
借入残高	なし（個人・事業ともに借入なし）
学術実績	査読論文65件・学術賞受賞5件以上・10学会所属・国際特許1件（WO2018-061201）
代診医	松島俊介先生（医療法人社団 聖山会 川南病院）

5．立地・商圏の優位性

要因	内容	クリニックへの影響
県道沿い角地・日常動線上の高視認性	県道に面した角地への立地を計画。複数方向からの進入が可能な配置を想定。マックスバリュ・ダイレックスへの買い物ルート近傍に位置し、地域住民の日常的な通行量が見込まれる	通勤・買い物途中のドライバーに日常的に露出しやすく、「ついでに受診」「帰宅途中に寄れる」という通院行動が期待できる。継続的な認知蓄積が見込まれる立地条件
商圏人口の多様性	学園台・まなび野・本郷（30〜40代子育て世代）／木花・熊野（宮崎大学関係者）／清武・田野（既存住民・高齢者）	一次商圏（半径1.5km）に多層的な患者層が存在し、特定層に依存しない安定した患者基盤を形成できる
宮崎大学・看護大学	教職員・学生が集積する知識層エリア	DX・Web問診への親和性が高い患者層。自費診療（AGA・GLP-1・LOH症候群等）の潜在需要も見込まれる
設備・DX優位性	開業準備時点の調査では、エリア内でWeb予約・問診・クラウド電子カルテをフル導入するクリニックは見当たらない。既存クリニックは院長高齢化が進んでおり、長期にわたる安定的な医療供給という点で差別化が期待できる	完全DXと長期にわたる安定した医療供給の両面で明確な差別化が可能

木花のむら診療所　開業計画概要書

資金・収支計画

2026年8月6日　院長　野村 信介

6．初期投資・融資計画

区分	用途	金額（万円）	返済期間
設備資金（建物）	木造2階建・建物本体・CT室放射線遮蔽工事込み・外構・造成・設計料・予備費	約14,500	20年
設備資金（土地）	土地購入費・不動産取得税・登記・測量	約2,750	20年
医療機器購入費（CT含む）	16列CT本体（リファービッシュ）・経鼻内視鏡システム（リファービッシュ）・FeNO測定器・消耗品初期ストック	約2,350	7〜10年
開業準備資金	IT・HP・看板・内覧会・採用・備品・医師会費	約685	7〜10年
諸費用・調整	開発許可・許認可・保険等	約300	7〜10年
運転資金	開業初期赤字・保険診療入金2ヶ月遅れ対応	約2,500	7〜10年
融資希望合計		**約23,085**	

※ 担保設定可能な資産：①購入予定土地（本融資にて取得）　②自宅不動産（院長所有）　③院長個人資産 約8,000万円（現預金・有価証券等）。土地・自宅の不動産担保に加え、個人資産による返済余力を有しており、融資保全の観点から十分な担保力を備えている。

※ デジタルX線・超音波エコー・経鼻内視鏡はリファービッシュ品、心電図は中古品で購入。FeNOは購入形態確認中。月額リースなし。金額は見積確定後に更新予定。

※ 建物工事にCT室放射線遮蔽工事（500万）を含む。16列CT本体（2,000万・リファービッシュ）と合わせてCT関連費用計2,500万を開業時より計上。

7．開業時スタッフ計画・人件費内訳

職種	人数	月額給与	小計
看護師（常勤）	3名	約29〜32万円	約90万円
医療事務（常勤）	2名	約20〜22万円	約42万円
フロアコンシェルジュ	1名	約20万円	約20万円
パートスタッフ（看護・事務補助）	1名	約15万円	約15万円
法定福利費・賞与積立（月割）	—	—	約53万円
スタッフ人件費 合計（院長報酬除く）			**約220万円**

【給与水準の根拠】

宮崎県最低賃金（2025年11月16日適用開始）：1,023円/時。所定労働8時間×22日＝176時間/月換算で最低賃金ベースは約180,000円/月。

・**看護師（常勤）29〜32万円**：時給換算1,648〜1,818円。最低賃金の約1.6〜1.8倍。宮崎市内クリニック看護師の相場（25〜33万）の中央値。夜勤なし外来専従として競争力のある水準。

・**医療事務（常勤）20〜22万円**：時給換算1,136〜1,250円。最低賃金の約1.1〜1.2倍。医療事務資格・レセプト経験者を想定した相場水準。

・**フロアコンシェルジュ 20万円**：時給換算約1,136円。最低賃金の約1.1倍。高齢者DX支援・院内案内を担う接客経験者を想定。

・**パートスタッフ 15万円**：時給換算約1,456円（週4日・6時間想定）。最低賃金の約1.4倍。

・**法定福利費・賞与積立**：給与総額167万に対し、社会保険料（事業主負担約15%）＋賞与2ヶ月分の月割（約16%）＝約31%で計53万。

【採用戦略】 診療は月曜〜金曜のみ（土日完全休日）とすることで、スタッフの働き方が「週休2日固定・夜勤なし・残業なし」という医療職に普及しつつある働き方改革の要件を満たす。採用難が続く現在の医療労働市場においても、「土日休みのクリニック」は看護師・医療事務職の求人競争力が高く、質の高い応募者の確保を期待している。

8．月次固定費の内訳

費目	備考	月額（円）
人件費（スタッフ）	看護師3・事務2・他	220万円
薬品・消耗品	季節変動あり	80万円
IT・読影・サブスク	クラウドEMR含む	9万円
光熱費	CT電力込み	12万円
保険・広告・雑費		30万円
CT保守費	固定費	15万円
CT読影費	梅村医師・2,000円/件（変動費・件数比例）	安定期約20万円
借入返済（元利均等）	据え置き中：35万円	約142万円
医師会費		3万円
合計（通常返済時）	**据え置き中：約402万円（読影費除く固定分）**	**約509万円**

※ デジタルX線・超音波エコー・経鼻内視鏡・16列CTはリファービッシュ品、心電図は中古品で購入。FeNOは購入形態確認中。月額リースなし。
※ 院長生活費（事業主貸）は別途（M1〜6：月100万、M7〜：月125万・年最大1,500万。法人成り後に改めて設計）
※ 融資総額約23,085万・金利1.8%想定。20年返済分（17,250万）84万/月＋10年返済分（5,835万）58万/月＝142万/月。据え置き1年間は利息のみ（約35万/月）。
※ CT読影費は変動費（梅村医師・2,000円/件）。薬品・消耗品費も変動要因あり：内視鏡1件あたり2,000〜3,000円（件数比例）、ワクチンシーズン+10〜15万円の季節変動を見込む。

9．資金繰り概要（診療圏調査ベース・据え置き1年・運転資金2,500万円から開始）

月	患者/日	現金入金	支出（生活費込）	手元残高
開始	—	—	—	2,500万
M1	25人	30万	483万（据え置き中）	2,047万
M2	35人	30万	483万	1,594万
M3	42人	305万	483万	1,416万
M4	48人	475万（CT収入60万含む）	516万	***1,332万（最低点）***
M5	52人	564万（CT収入72万含む）	517万	**1,379万（月次黒字転換+47万）**
M9	62人	668万	508万（据え置き中）	**約1,800万**
M13〜	65人	855万（CT収入110万含む）	653万（返済開始）	**+202万/月**
M18〜	70人	920万（CT収入120万含む）	654万	**+266万/月**

※ 保険診療・CT検査収入は診療月の翌々月に入金。M1・M2は自費収入30万円のみを入金計上。CT読影費は撮影月に先払い（収入より2ヶ月先行）。据え置き期間（M1〜12）は利息のみ35万円/月を計上。M13より元利均等返済（142万/月）開始。手元残高の最低点はM4（1,332万）。運転資金2,500万に対し余裕1,168万円。

１０．現職クリニックでの実績（参考）

指標	実績値	備考
通常時の1日来院患者数	**約150人/日**	常勤医2名＋非常勤体制
冬季ピーク来院患者数	**約250人/日**	インフルエンザ・感染症期
現職の年収	**1,500万円**	副院長（2023年10月〜現在）

当院の安定期目標（70人/日）は現職実績の半数以下の保守的な設定です。

１１．地域医療関係・バックアップ体制

医師会	宮崎市郡医師会 A会員として加入予定。牛谷義秀副会長（防衛医大同門）と面識あり
代診医	松島俊介先生（医療法人社団 聖山会 川南病院）
土曜非常勤	松島先生による土曜午前対面診療を検討中
連携医療機関	宮崎大学医学部附属病院・宮崎県立宮崎病院へ紹介ルートを確保予定（現在の宮崎大学助教歴・早水公園クリニック副院長経由の既存ネットワークを活用）
設計事務所	AAO建築アトリエ——設計進行中（2026年7月30日 三社MTG実施済み）

１２．将来的な成長余地

成長要因	患者数への影響	月次余剰への影響
イシャチョク®による開院初期の収益平準化 開院初日より導入・閑散時間帯の補完活用	対面換算+3〜5人/日分 （損益分岐点を実質4人/日引き下げ）	+約25〜44万円/月 （3〜5件/日×4,000円×22日）
	中休み（12:15〜13:45）等の閑散時間帯に仮想待合室型オンライン診療プラットフォーム「イシャチョク®」を活用し、全国患者とのオンライン診療を実施（単価4,000円/件）。対面外来の合間に待機するだけで新規患者の診察が可能で、開業初期において補完収益を確保。初診後は当院への対面通院を促す導線としても機能する。	
土日夕方・完全予約制 外科処置外来 開院後・需要確認後に導入検討	+5〜10人/回 （土日各1枠・月8回）	+約30〜80万円/月 （処置単価・件数による）
	土日17:00〜18:30に完全予約制で外科処置外来を開設検討。皮膚腫瘤切除・陥入爪・巻き爪・創傷縫合処置等を院長単独で対応。平日通院困難な就労世代を取り込み、初回処置後の再診サイクルで継続収益を確保。	
施設往診の開始 開院1〜2年目〜	外来換算 +15〜25人/日相当	+130〜210万円/月 （50〜80名・中央値+170万）
	近隣介護施設との定期訪問契約締結を目指す。非在宅療養支援診療所として施設入居者50〜80名の担当を想定。施設入居時等医学総合管理料（月2回訪問・約2.8万円/人/月）。外来診療の合間に院長が対応できる体制を計画中。	
大腸内視鏡の追加 開院2〜3年目	+5〜10人/日	+約65〜130万円/月
	上部消化管内視鏡の稼働状況・需要を見極めたうえで、大腸内視鏡の追加導入を検討する予定。設計段階からスケルトン対応済みのため、需要が確認できた時点で最小限のコストで導入が可能。	
高齢院長クリニックの診療体制変化による患者流入 開院後5〜10年以内	+40〜60人/日 （閉院患者の20〜30%）	+約290〜430万円/月
	診療圏内の院長年齢70歳以上のクリニック（亀山記念・小緑内科・滝口内科・坂本医院・ひろの内科）は院長の高齢化が進んでおり、中長期的に診療体制が変化する可能性がある。その際に行き場を求める患者（5院合計推計約200人/日）の一部が当院へ流入することを期待できる。	
山下橋（清武川）開通 開院後約10年・2037年頃	+12〜18人/日 （中央値+15人）	+約200万円/月
	計画交通量9,300台/日（国交省計画）。現在迂回が必要な東宮・希望ヶ丘・まなび野・本郷地区（人口約2.8万人）の一部が診療圏内に入る。新たにアクセス可能となる人口推計約1〜1.5万人。	
CT件数の拡大・大腸内視鏡追加 開業時CT導入済み・安定期以降に件数増・M24〜大腸	+5〜15人/日 （CT目的受診・近隣クリニックからの紹介流入）	CT収入+20〜30万/月 読影費（変動費）と相殺後の純増
	CT（16列リファービッシュ）は開業時より導入済み。安定期以降にCT件数拡大（月100件→150件）と近隣クリニックからの紹介受け入れを強化。肺がん2次検診・腹部救急（胆嚢炎・尿管結石・虫垂炎等）の診断精度向上により地域医療への貢献度を高める。M24〜は大腸内視鏡も導入予定（建物スケルトン設計対応済み）。	

成長要因	患者数への影響	月次余剰への影響
短期融資の完済 2038年頃	—	+35万円/月
	短期借入（医療機器購入費・開業準備・運転資金 計5,835万）の10年返済が完了し、月次返済額が削減される。	

※ 安定期（M18〜）月次余剰+266万円を基準とした積み上げ試算。診療体制変化・施設往診・大腸内視鏡・CT件数拡大・山下橋開通・短期融資完済が順次実現した場合、試算上は2038年以降に月次余剰+1,000万円超となる可能性がある。いずれも診療圏調査（成人35名＋小児16名＝51名）の試算値には含まれていない上積み要因として位置づけており、確約ではなく将来シナリオとして提示している。院長44歳開業・65歳完済（20年ローン）の設計で、地域への長期安定的な医療供給と経営の持続性を両立する計画である。

参考．診療圏内 既存内科医療機関状況

地区	医院名	開設年	院長推定年齢 ※公開情報等より推定	開設年数
木花・青島地区	**木花のむら診療所（当院）**	**2027年**	**44歳**	**新規開院**
木花・青島地区	学園台クリニック	1986年	60歳後半	約40年
	このはな生協クリニック	1990年	60歳半ば	約35年
	亀山記念クリニック	1993年	70歳	約30年
	小緑内科クリニック	1992年	71歳	約30年
清武地区	坂本医院	1980年	60歳後半	約45年
	きよたけクリニック	1996年	68歳	約30年
	城山病院	1946年	68歳	約80年
本郷・まなび野地区	井出医院	1999年	60歳後半	約25年
	いといクリニック	2015年	60歳前半	約10年
	滝口内科	1990年	78歳	約35年
	山内ファミリークリニック	2000年	60歳	約25年
	竜内科クリニック	1981年	46歳	約45年
	日高医院	1995年	64歳	約30年
	川名クリニック	1992年	60歳後半	約35年
	はるやま医院	2021年	50歳	約5年
	ひろの内科クリニック	2001年	69歳	約25年

※ 診療圏内の既存医療機関は開設25〜80年・院長年齢60〜70代が大半を占める。院長の高齢化・設備老朽化により中長期的に診療体制が変化するリスクがある。当院（院長44歳・2027年開院）は長期にわたり地域医療を担い続ける新設クリニックとして、需要の受け皿となる見込み。